

Опыт клинико-экспериментальных исследований в области рефлексотерапии

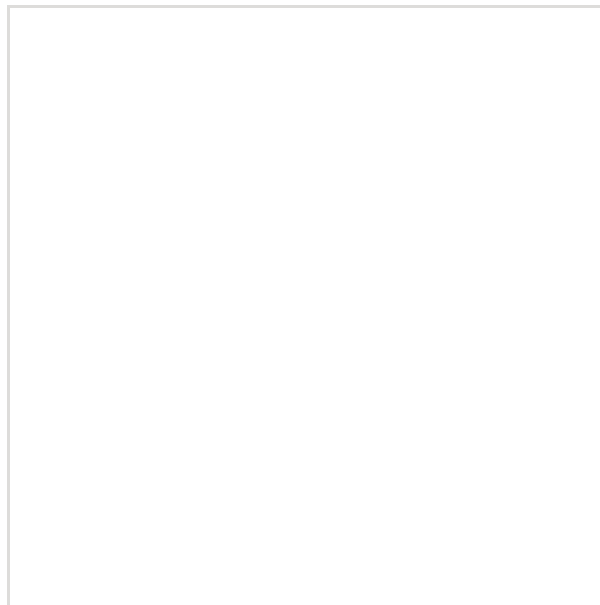
Материалы статьи на концептуальном уровне обобщают результаты собственных исследований, направленных на научное обоснование применения рефлексотерапии. В ходе уточнения значимых механизмов метода впервые экспериментально подтверждена первостепенность несп

#07-08/22 (/2022/07-08) Ключевые слова / keywords: Дорсопатии (/rub/11019034), Ревматология (/rub/11000040), Рефлексотерапия (/rub/11000837), Сексуальные дисфункции (/rub/11008097), Спектральная фототерапия (/rub/11021367), Терапия (/rub/11000090), Фармакопунктура (/rub/11018185), Экспериментальная терапия (/rub/11018314), Dorsal pain (/rub/11019034), Rheumatology (/rub/11000040), Reflexotherapy (/rub/11000837), Sexual dysfunction (/rub/11008097), Spectral phototherapy (/rub/11021367), Therapy (/rub/11000090), Pharmacopuncture (/rub/11018185), Experimental therapy (/rub/11018314)

Л. Г. Агасаров (/author/4536707)

Резюме. Материалы статьи на концептуальном уровне обобщают результаты собственных исследований, направленных на научное обоснование применения рефлексотерапии. В ходе уточнения значимых механизмов метода впервые экспериментально подтверждена первостепенность неспецифической реакции, воспроизводящей адаптацию к повторному действию мягкого стресса. Данный феномен зафиксирован и на практике в виде идентичности реакций на различные виды зональной электростимуляции. Помимо этого основополагающего звена, при анализе отдельных способов прослеживаются и дополнительные влияния. Так, при пояснично-крестцовых дорсопатиях достоверное превосходство фармакопунктуры (введения лекарственных средств в область точек рефлексотерапии) над сравниваемыми методами проявлялось и в положительных структурно-модифицирующих изменениях пораженных межпозвонковых дисков. Еще одной результативной методикой, в том числе и в отношении дорсопатий, является спектральная фототерапия – раздражение рефлексогенных зон и точек низкоэнергетическими источниками света со спектрами испускания различных химических элементов. Среди других приоритетных направлений в ходе коррекции социально-стрессовых расстройств у лиц опасных профессий (сотрудников силовых ведомств, участвующих в локальных операциях, и ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС) был отмечен приоритет сочетания психологической коррекции и низкочастотного электромагнитного воздействия – пульсогемоиндикации. В блоке исследований по сексологии у одной трети практически здоровых мужчин до 35 лет зафиксировано отчетливое снижение половой активности в виде типового патологического состояния из гуморальных, невротических и вазоспастических компонентов. Подобное

переплетение звеньев выявлено и при сексуальных нарушениях, патогномичных для мужчин с пояснично-крестцовыми дорсопатиями. В процессе выбора способов восстановления сексуальной активности были учтены экспериментальные данные о стресс-лимитирующем влиянии различных технологий. Однако на практике подтверждена высокая результативность спектральной фототерапии как в профилактическом, так и лечебном отношении. Приведенные исследования нашли отражение в многочисленных публикациях, включая монографии, патентах на изобретения и материалах проводимых нами конференций.



Статья в реферативном стиле обобщает более чем тридцатилетний опыт собственных исследований в области экспериментальной медицины применительно к такой лечебно-профилактической системе, как рефлексотерапия. С некой долей гиперболы это направление само по себе можно рассматривать как экспериментальное, поскольку при объяснении его механизмов приходится балансировать между древними восточными и современными гипотезами [9]. Ориентируясь на последние, понятные для врача, рефлексотерапия представляется «системой поддержки гомеостаза и целенаправленной коррекции патологических состояний путем стимуляции цепей рефлексогенных локусов (обозначааемых как точки рефлексотерапии) различными факторами, преимущественно физической природы» [1]. Наблюдаемые при этом эффекты стереотипно объясняют с позиций рефлекторной теории в виде цепи взаимосвязанных реакций от местной до генерализованной [13]. Это объяснение было предложено еще в середине двадцатого столетия и по большому счету приложимо к любому виду физической стимуляции. При всей стройности, данная теория все же отражает только одно, наиболее наглядное анальгетическое влияние метода, при игнорировании других его возможностей. В этом плане значимую (если не первостепенную) роль может играть неспецифическая реакция, близкая к адаптации, на повторное воздействие «мягкого» стресса и, как следствие, сглаживающая выраженность гиперadreналовых реакций. Данный тезис был подтвержден нами опытным путем – реакцией крыс на единичную процедуру рефлексотерапии, однотипной с ответом на стрессогенный фактор в виде полярного изменения значений ключевых звеньев – кортикостерона и β -эндорфина. С другой стороны,

нивелирование у животных реакции на стресс как таковой по завершении курсового воздействия сочетается с инверсией соотношения указанных показателей [17]. Выявленный феномен также подтвержден клинически, а именно однонаправленностью физиологических реакций на различные виды физического воздействия [18], включая локальную электростимуляцию. Помимо этого основополагающего звена, в современных способах рефлексотерапии прослеживаются и дополнительные корректирующие механизмы. Здесь в первую очередь следует выделить биопунктуру (в узком понимании – фармакопунктуру): кожную или инъекционную стимуляцию точек рефлексотерапии разнообразными активными агентами – эфирными маслами, медицинским озоном, лекарственными средствами и др. [7, 10]. При введении медикамента в проекцию точек рефлексотерапии его выбор определяется характером патологии соответственно базовым принципам клинической фармакологии, а саму технику можно трактовать как оригинальную разновидность медикаментозных блокад, к примеру, по Аствацатурову. Собственная монография «Фармакопунктура» [2], систематизировавшая разрозненные на момент выпуска сведения, была опубликована в России первой. В данной комбинированной технологии выделяют несколько лечебных механизмов. В частности, сдвиг объемных характеристик тканей в ответ на инъекцию в них жидкости обеспечивает длительное раздражение точек рефлексотерапии. Принимают во внимание и терапевтическое значение образуемых множественных депо препарата. И, наконец, предполагают интимное взаимодействие точки и препарата в соответствии с принципом «ключ к замку», что в свою очередь является поводом к многочисленным научным спекуляциям. Это спорная в обосновании, но действенная методика, показательным примером чего является ее использование при пояснично-крестцовых вертеброгенных синдромах (дорсопатиях). В данных исследованиях подтверждено однозначное превосходство фармакопунктуры над другими сравниваемыми способами, проявляющееся и в структурной модификации пораженных межпозвонковых дисков [8, 15]. Объяснение этого феномена, отмеченного только в случае фармакопунктуры, лежит, на наш взгляд, в плоскости низкоэнергетических механизмов стимуляции. К результативным и отсюда перспективным методам физической медицины следует отнести и спектральную фототерапию – «стимуляцию рефлексогенных зон или точек низкоэнергетическими источниками света со спектрами испускания различных химических элементов» [6]. С целью коррекции состояния различных органов и систем на практике используют специальные лампы с полым катодом со спектром излучения строго определенных химических элементов. В частности, при сочетанной патологии локомоторной и сердечно-сосудистой системы приоритетными являются калий, кальций, марганец и натрий. Использование данного способа сопровождается рядом эффектов, выходящих за рамки, свойственные рефлексотерапии. К примеру, в условиях эксперимента показано, что 1,5-минутное воздействие на локусы лампой со спектром испускания марганца обеспечивает двукратное увеличение концентрации этого элемента в крови [8]. Возвращаясь к модели пояснично-крестцовых дорсопатий, можно отметить, что спектральная фототерапия и здесь значительно (на уровне достоверности) превосходит другие сравниваемые способы, включая общепринятый терапевтический комплекс. Приоритетная серия исследований посвящена оценке механизмов и коррекции социально-стрессовых расстройств у лиц опасных профессий – представителей силовых ведомств, участвующих в локальных операциях, и ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС (далее –

ликвидаторов). Выбор и сопоставление этих двух групп объяснялись различием в механизмах стрессирования, а сам процесс характеризовался доминированием в клинической картине невротических и кардиоваскулярных сдвигов. Исследования выполняли в разновозрастных группах пациентов, наблюдая при этом за статусом ликвидаторов на протяжении более 10 лет [11, 12]. На момент первичного общения проявления стресса у ликвидаторов уже носили отчетливый (причем полиморфный) характер, тогда как у ветеранов силовых ведомств прослеживалось доминирование аффективных реакций при умеренной выраженности астеноневротизации. При этом типичные для ликвидаторов среднего возраста соматические жалобы преимущественно функционального типа в последующем сменялись устойчивой артериальной гипертензией. В ходе обследования сотрудников силовых ведомств среднего возраста был отмечен удовлетворительный уровень физического здоровья. Тем не менее у 23% из этих лиц отмечались сердечно-сосудистые нарушения в виде кардиалгий и ряда других признаков, нарастающих с течением лет по интенсивности и приобретающих характер органической патологии. На первом этапе работы применительно к невротическим проявлениям был отмечен приоритет двух способов психологической коррекции – аутогенной тренировки и дыхательно-релаксационного тренинга. Однако вполне понятная их низкая результативность в отношении кардиальных расстройств определила дополнительное применение низкочастотного электромагнитного воздействия – пульсогемоиндикации, обеспечивающей коррекцию сосудистых сдвигов по принципу обратной связи. Предложенный комплекс был достоверно результативнее других подходов и приводил к улучшению ряда ключевых показателей (в том числе качества жизни) в трети наблюдений в обоих сравниваемых контингентах [12]. Следующее развиваемое направление, базирующееся на разработанных нами клинических рекомендациях [16], затрагивает вопросы мужской сексологии и сексopatологии. В формате лечебно-профилактических мероприятий в нескольких регионах страны (Москва, Ростовская область, Краснодарский край) было выполнено обследование так называемых практически здоровых мужчин в возрасте до 35 лет. В результате установлено отчетливое и достоверное снижение уровня половой активности у 36% опрошенных [5]. В этом плане красноречивым, хотя и несколько патетичным является высказывание о «выходе проблемы охраны здоровья мужчин за рамки здравоохранения... и теснейшей связи с состоянием национальной безопасности» (Ш. Н. Галимов, 2008). При этом, в противовес догме об избирательности поражения одного из звеньев копулятивного цикла, нами описано характерное для данных лиц типовое патологическое состояние – по аналогии с типовой реакцией – в виде триады из гуморальных (срыв обратной связи «гонады – гипофиз» на фоне ослабления половой конституции), невротических и вазоспастических компонентов [4]. В развитие этого положения были детализированы и патофизиологические механизмы уже имеющихся сексуальных нарушений, патогномичных для мужчин с хроническим течением пояснично-крестцовых дорсопатий. Хрестоматийно их связывают с поражением крестцового отдела позвоночника – одного из центров эрекции, при игнорировании другого, локализованного в поясничной области. Подобное дублирование центров, столь расточительное для природы, дополненное участием в процессе обоих отделов вегетативной нервной системы, отражает максимум защищенности эрекционного рефлекса – за исключением тотальных травматических или облитерирующих

воздействий. И в случае дисфункций на фоне дорсопатий подтверждена роль той же триады из гуморальных, астенических и обратимых сосудистых механизмов, доминирующей над собственно неврологическим дефектом [4].

Что касается профилактики, неблагоприятное снижение половой активности у относительно молодых мужчин определило целесообразность использования мягких превентивных мер, к которым в 2000-х годах относили прием гомео- и фитопрепаратов. Соответственно, в этот период при ведомственном контрольном центре функционировала комиссия по препаратам природного происхождения и гомеопатическим лекарственным средствам. С целью уточнения их результативности нами была запланирована экспериментальная работа. В ходе ее выполнения животные основной группы, в отличие от сравниваемой, ежедневно в течение двух недель получали растворенный в воде гомеопатический препарат психотропной направленности. Исходно и по завершении этого срока оценивали поведение крыс в тесте «открытое поле», а затем последовательно подвергали острому стрессу и декапитации, соотнося в финальной стадии массу надпочечников и тимуса с контрольными величинами. Отмеченные при этом сдвиги поведенческих реакций и морфологических характеристик достоверно подтверждали умеренное стресс-лимитирующее влияние препарата [3].

К сожалению, применительно к наблюдаемым мужчинам специфическая результативность гомеопатических средств была сопоставима с эффектом плацебо, сопровождаясь при этом незначительным андрогенным влиянием. Учитывая это, мы дополнили медикаментозное воздействие физическим, в частности, динамической электростимуляцией. Выбор последней определялся данными о ее стресс-лимитирующем эффекте, проявляющемся в снижении содержания кортикостероидов и предупреждении гипергликемии у животных с аллоксан-индуцированным сахарным диабетом [14]. Предложенный комплекс действительно обеспечивал рост эффективности, однако достоверно уступал в этом отношении другому методу – уже упомянутой спектральной фототерапии. В ответ на ее применение подавляющее большинство мужчин отметило улучшение сексуальных функций, подтвержденное позитивными гормональными, психическими и сосудистыми сдвигами [5]. Кроме того, метод был результативен и при уже сформированных половых расстройствах у мужчин с дорсопатиями [4].

В целом, что касается внедрения в практику, проведенные исследования нашли отражение в публикациях, включая многочисленные монографии, пособия и патенты на изобретение, материалах общероссийских и региональных конференций, курируемых нами, а также в научно-практическом журнале профильной ассоциации «Рефлексотерапия и комплементарная медицина».

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Автор статьи подтвердил отсутствие конфликта интересов, о котором необходимо сообщить.

CONFLICT OF INTERESTS. Not declared.

Литература/References

1. Агасаров Л. Г. Руководство по рефлексотерапии: учебное пособие. М., 2001. 304 с. [Agasarov L.G. Guide to reflexology: a textbook. M., 2001. 304 p.]
2. Агасаров Л. Г. Фармакопунктура. М., 2002. 192 с. [Agasarov L.G. Pharmacopuncture. M., 2002. 192 p.]

3. Агасаров Л. Г. Столяренко Н. А., Петров А. В. Использование препарата «Нирвана – ЭДАС» в лечебной практике // Опыт и проблемы развития традиционных методов лечения в России. 2003; (3): 155-156. [Agasarov L. G. Stolyarenko N. A., Petrov A. V. Use of the drug «Nirvana – EDAS» in curative practice // Experience and problems of development of traditional methods of treatment in Russia. T. 3. 2003. P. 155-156.]
4. Агасаров Л. Г., Разумов А. Н. Традиционная медицина в восстановлении сексуального здоровья мужчин. М., 2006. 197 с. [Agasarov L. G., Razumov A. N. Traditional medicine in the restoration of sexual health of men. M., 2006. 197 p.]
5. Агасаров Л. Г., Гурцкой Р. А. Мужское сексуальное здоровье и способы его восстановления. М., 2011. 62 с. [Agasarov L. G., Gurtsoy R. A. Men's sexual health and ways of its recovery. M., 2011. 62 p.]
6. Агасаров Л. Г. Рукин Е. М. Спектральная фототерапия в восстановлении половой деятельности мужчин / Инновационные технологии в диагностике и лечении внутренних болезней. Новосибирск, 2012. С. 94-96. [Agasarov L. G. Rukin E. M. Spectral phototherapy in the restoration of sexual activity of men / Innovative technologies in the diagnosis and treatment of internal diseases. Novosibirsk, 2012. P. 94-96.]
7. Агасаров Л. Г., Герасименко М. Ю., Кончугова Т. В. Фармакопунктура при распространенных патологических состояниях. Клинические рекомендации. М., 2017. 38 с. [Agasarov L. G., Gerasimenko M. Yu., Konchugova T. V. Pharmacopuncture in common pathological conditions. Clinical guidelines. M., 2017. 38 p.]
8. Агасаров Л. Г. Рефлексотерапия при распространенных заболеваниях нервной системы. М., 2017. 240 с. [Agasarov L. G. Reflexotherapy in common diseases of the nervous system. M., 2017. 240 p.]
9. Агасаров Л. Г., Василенко А. М., Радзиевский С. А. Организационные и научные аспекты рефлексотерапии // Вестник новых медицинских технологий. 2018; 4: 51-56. [Agasarov L. G., Vasilenko A. M., Radzievskiy S. A. Organizational and scientific aspects of reflexotherapy // Vestnik novye meditsynkh tehnologii. 2018, № 4. P. 51-56.]
10. Агасаров Л. Г. Локальная инъекционная терапия при мышечно-суставном болевом синдроме. Новосибирск, 2020. 48 с. [Agasarov L. G. Local injection therapy for muscular-articular pain syndrome. Novosibirsk, 2020. 48 p.]
11. Бокова И. А., Агасаров Л. Г. Типология и коррекция постстрессовых расстройств различного генеза // Вестник новых медицинских технологий (электрон. издание). 2020; 1: 6. [Bokova I. A., Agasarov L. G. Typology and correction of post-stress disorders of various genesis // Bulletin of new medical technologies (electron. Edition). 2020, № 1, 6 p.]
12. Бокова И. А., Агасаров Л. Г. Инновационный комплекс коррекции постстрессовых нарушений // Лечащий Врач. 2021; 5: 14-16. [Bokova I. A., Agasarov L. G. Innovative complex of correction of post-stress disorders // Attending physician. 2021, № 5. P. 14-16.]
13. Василенко А. М., Осипова Н. Н., Шаткина Г. В. Лекции по рефлексотерапии. М., 2002. 361 с. [Vasilenko A. M., Osipova N. N., Shatkina G. V. Lectures on reflexology. M., 2002. 361 p.]
14. Егоркина С. Б., Султанов И. Р., Нафталиев Р. И. и др. Результаты проведения динамической электростимуляции в условиях экспериментального аллоксан-индуцированного сахарного диабета и хронического иммобилизационного стресса у крыс / Динамической электростимуляция – современная технология восстановительной медицины. М., 2008. С. 20-23. [Egorkina S. B., Sultanov I. R., Naftaliev R. I. et al. Results of dynamic electrical stimulation in conditions of experimental alloxan-induced diabetes mellitus and chronic immobilization stress in rats / Dynamic electrical stimulation – modern technology of restorative medicine. M., 2008. P. 20-23.]
15. Макина С. К., Агасаров Л. Г., Готовский М. Ю. Структурно-модифицирующее влияние комплекса частотно-волновой терапии и фармакопунктуры при дорсопатиях // Традиционная медицина. 2012; 4: 4-7. [Makina S. K., Agasarov L. G., Gotovsky M. Y. Structural-modifying influence of the complex of frequency-wave therapy and pharmacopuncture in dorsopathy // Traditional medicine. 2012, № 4. P. 4-7.]
16. Агасаров Л. Г., Васильченко Г. С., Карпов А. С. и др. Методические рекомендации по клиническим испытаниям новых лекарственных средств, применяемых в мужской сексологии и сексопатологии // Ведомости НЦ экспертизы и государственного контроля лекарственных средств. 2002; 2: 18-23. [Agasarov L.G., Vasilchenko G.S., Karpov

A.S. et al. Guidelines for clinical trials of new drugs used in male sexology and sexopathology // Vedomosti NC expertise control of medicines. 2002, № 2. P. 18-23.]

17. Радзиевский С. А., Агасаров Л. Г., Бобровницкий И. П. и др. Адаптивные механизмы кардио- и сосудопротекторного действия рефлексотерапии // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. 2013; 1: 55-59rb. [Radzievsky S.A., Agasarov L.G., Bobrovnitsky I.P. et al. Adaptive mechanisms of cardio- and vasoprotective effect of reflexotherapy // Voprosy balneologii, physiotherapy i exercise therapy. 2013, № 1. P. 55-59.]
18. Радзиевский С. А., Орехова Э. М., Агасаров Л. Г. и др. Обоснование применения трансаурикулярной и транскраниальной электростимуляции для формирования стресс-протекторного эффекта // Вестник новых медицинских технологий. 2016; 2: 110-113. [Radzievskiy S.A., Orekhova E.M., Agasarov L.G. et al. Substantiation of the use of transauricular and transcranial electrical stimulation for the formation of a stress-protective

Острый риносинусит



(<https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=177607&ad=746069&bid=14204441&bt=43&bn=7&pz=0&nid=0&ref=http>
РЕКЛАМА 9rAW5Z7fz7P1KJt8DU&rleurl=)

Купить номер с этой статьей в pdf (<https://www.osp.ru/store/lvrach/2022/07-08>)

Lvrach.ru – крупнейший профессиональный ресурс для врачей и медицинского сообщества, созданный на базе научно-практического журнала «Лечащий врач».

Свидетельство о регистрации сетевого издания Эл.№ ФС77-62383 от 14 июля 2015 г. выдано Роскомнадзором.

Политика обработки персональных данных (<https://www.lvrach.ru/personalpolicy>)

Сообщество в VK (<https://vk.com/lvrach>)

Подписывайтесь на наш канал в Telegram (<https://t.me/lvrach>)

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен (<https://dzen.ru/lvrachnews>)

КОНТАКТЫ

Адрес для писем:
123056, Россия, г. Москва, а/я 82
newsvrach@lvrach.ru (<mailto:newsvrach@lvrach.ru>)
Тел. +7(495) 725-47-80 (tel:+74957254780)

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Маргарита Бабаян (rita@osp.ru) (<mailto:rita@osp.ru>)

Возрастная маркировка: 16+
Средство массовой информации
www.lvrach.ru (<https://www.lvrach.ru>)



(<https://www.osp.ru>)

Учредитель:
ООО «Издательство «Открытые

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ

Светлана Иванова (lana@osp.ru) (mailto:lana@osp.ru)

ИНФОПАРТНЕРСТВО

marketing@lvrach.ru (mailto:marketing@lvrach.ru)

системы»

©1998-2026

ООО «Издательство «Открытые
системы»

ISSN 1560-5175 (Print)

ISSN 2687-1181 (Online)



(<https://www.liveinternet.ru/click>)

